proregen

GUIA PARA PACIENTES

Coluna e ortobiológicos

Um guia simples sobre dor nas costas e no pescoço e sobre o PRP e outros tratamentos preparados com recursos do seu próprio corpo.

Dr. André Kruel · Médico ortopedista
CRM-RS 23627 · RQE 14323

OUTUBRO 2026

BOAS-VINDAS

Informação clara para cuidar da sua coluna

Se você convive com dor nas costas ou no pescoço, saiba que não está sozinho — e que existem caminhos para voltar a se movimentar com mais conforto.

Este guia foi escrito como uma conversa de consultório: sem pressa e em linguagem simples. Aqui você vai entender por que a coluna dói, o que são os **ortobiológicos** — como o PRP — e como é o procedimento, do primeiro contato à recuperação.

Cada pessoa é única. Por isso, qualquer tratamento começa por uma **avaliação cuidadosa** e é decidido junto com você.

NESTE GUIA

- Por que a coluna dói
- O que são os ortobiológicos
- Como é o procedimento
- O que a ciência mostra
- Dúvidas frequentes

Um passo dentro de um plano completo

1

A base

Exercícios orientados, fisioterapia, sono, controle do peso e remédios quando indicados.

2

Procedimentos guiados

Quando a dor persiste, procedimentos precisos podem complementar o tratamento — é aqui que entram os ortobiológicos.

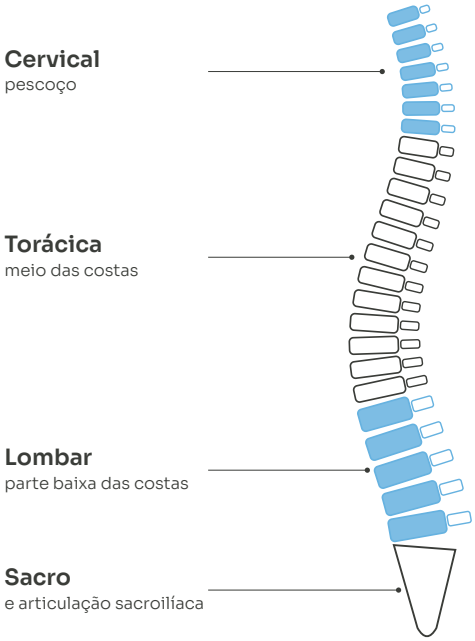
3

Cirurgia

Reservada para situações específicas, quando há indicação clara.

Os ortobiológicos são **um aliado** do movimento e da reabilitação — nunca um substituto.

Dor nas costas é comum — e tem explicação

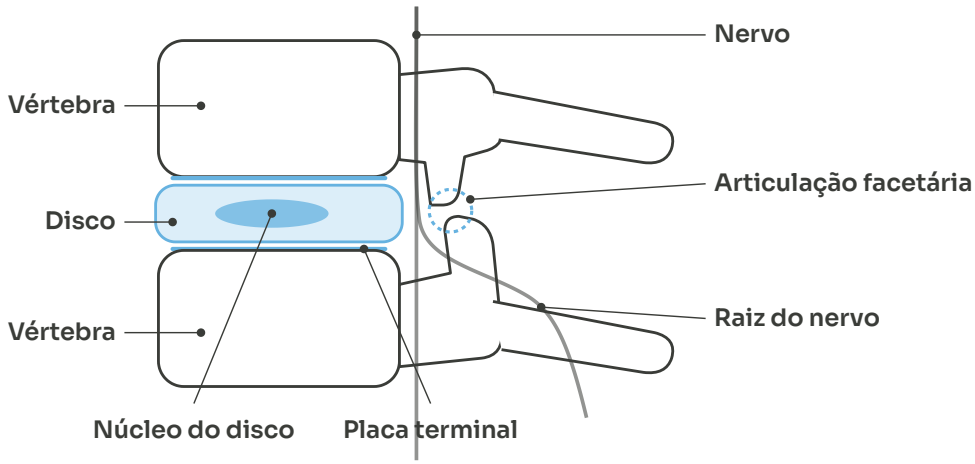


De 7 a 8 em cada 10 pessoas terão dor nas costas em algum momento da vida. Na maioria das vezes, a crise melhora em poucas semanas.

A coluna é formada por **vértebras** empilhadas. Entre elas ficam os **discos**, que funcionam como amortecedores. Atrás, pequenas articulações — as **facetárias** — guiam o movimento como dobradiças. Lá embaixo, a coluna se apoia na bacia pelas **sacroilíacas**.

Com o tempo, essas estruturas mudam naturalmente. Em algumas pessoas, essas mudanças ficam inflamadas e passam a doer.

> BOM SABER
>
> Imagem alterada nem sempre significa dor. O diagnóstico une a sua história, o exame físico e os exames — para descobrir **de onde a dor realmente vem**.



O disco tem um miolo macio envolvido por um anel de fibras. Pequenas fissuras podem inflamar e causar dor.

As articulações podem sofrer desgaste e inflamação, como acontece no joelho.

O nervo, quando irritado, faz a dor "descer" para a perna ou o braço.

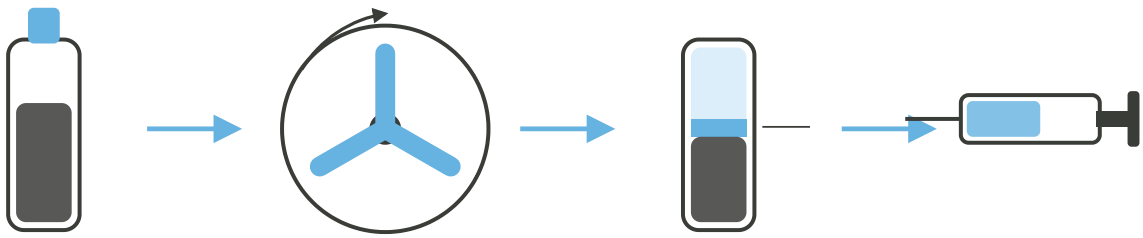
Ilustrações esquemáticas, fora de escala.

Recursos do seu próprio corpo

Ortobiológicos são preparados a partir de tecidos do próprio paciente — principalmente o sangue — e aplicados no local da dor.

O material é apenas separado e concentrado, sem cultivo em laboratório. A ideia é levar até a estrutura dolorida substâncias que o corpo já usa para controlar a inflamação e cicatrizar, como os **fatores de crescimento**.

Como o PRP é preparado



1. Coleta
do braço

2. Centrifugação
gira em alta velocidade

3. Separação
plaquetas concentradas

4. Aplicação
guiada por imagem

O **PRP (plasma rico em plaquetas)** é feito na hora, com uma pequena quantidade do seu sangue, coletada do braço como em um exame. Uma centrífuga separa as camadas do sangue e a parte mais rica em plaquetas é recolhida, em kit estéril e de uso individual.

PRP

Preparado com o seu sangue. É o ortobiológico mais usado e mais estudado na coluna.

O MAIS ESTUDADO

Concentrado de medula

Obtido da medula óssea do osso da bacia, com anestesia local.*

Derivados de gordura

Obtidos por uma pequena lipoaspiração, em geral da barriga.*

* Uso mais restrito, avaliado individualmente. Veja a nota informativa na página 8.

COMO É O PROCEDIMENTO

Do primeiro contato à recuperação

É um procedimento planejado, feito com anestesia local, técnica estéril e acompanhamento de perto. Na maioria dos casos, você volta para casa no mesmo dia.

1

Consulta e avaliação

Conversa, exame físico e revisão dos seus exames para entender de onde vem a dor e qual é o melhor plano.

2

Orientações e consentimento

Você recebe orientações sobre remédios e jejum e tira todas as dúvidas antes de assinar o termo de consentimento.

3

No dia, em ambiente hospitalar

O material é preparado na hora e aplicado com a agulha guiada por **raio-X ou ultrassom**, para chegar com precisão ao local certo.

4

Alta com orientações

Depois de um período curto de observação, você vai para casa com um roteiro de cuidados e retornos.

Como costuma ser a recuperação

Primeiros dias

Repouso relativo. Um desconforto local passageiro é esperado e faz parte do processo.

Semanas 2 a 6

Retorno gradual às atividades e aos exercícios orientados.

Meses 1 a 3

A melhora, quando acontece, costuma ser progressiva, não imediata.

Retornos

Consultas de acompanhamento para avaliar a evolução e ajustar o plano.

Para uma boa recuperação

- Evite esforço intenso nos primeiros dias.
- Siga o plano de exercícios e fisioterapia.
- Use apenas os remédios indicados pelo médico.

VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO

Dúvidas no pós-procedimento? Fale com a equipe pelo WhatsApp **(54) 99689-1295**.

DICA

Anote sua dor de 0 a 10 antes do procedimento e uma vez por semana depois. Isso ajuda você e o seu médico a acompanhar a evolução.

O QUE A CIÊNCIA MOSTRA

Um campo em crescimento, com bases sólidas

Os ortobiológicos vêm sendo estudados há mais de uma década em centros de pesquisa no mundo todo — e o conhecimento cresce a cada ano.

01

O mais estudado

O PRP aplicado no disco lombar é o uso com mais estudos. Muitos pacientes tiveram melhora da dor e da função ao longo de meses.

02

Perfil de segurança

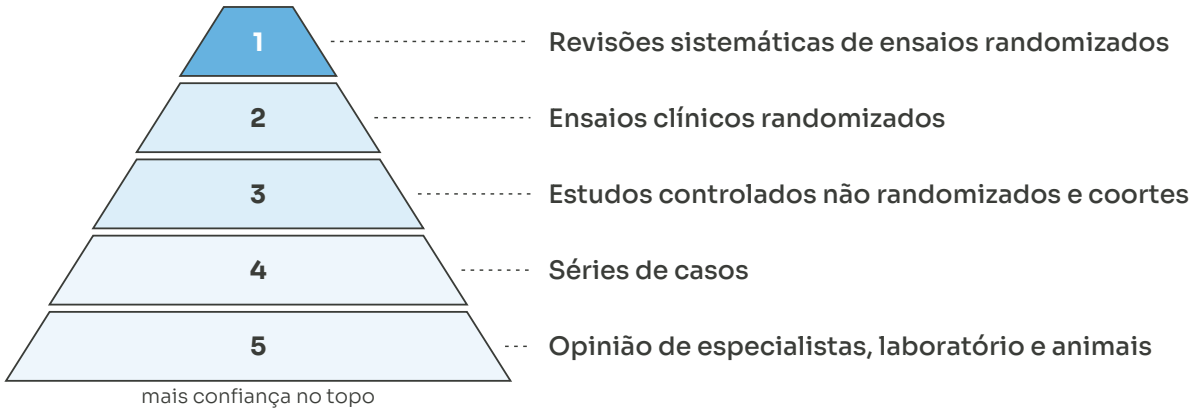
Por usar material do próprio corpo, não há risco de rejeição. Nos estudos publicados, complicações graves foram raras.

03

Reconhecimento no Brasil

Desde 2026, o Conselho Federal de Medicina reconhece o PRP como tratamento complementar na discopatia lombar.

Como a ciência organiza as evidências



Os estudos mais confiáveis comparam grupos de pacientes e são repetidos por equipes diferentes. É assim que o conhecimento avança: passo a passo, com cuidado. Cada resposta é individual — por isso a avaliação do seu caso é tão importante.

O objetivo é aliviar a dor e ajudar você a voltar às suas atividades, dentro de um plano completo de cuidado.

PERGUNTAS FREQUENTES

As dúvidas que mais ouvimos

P Dói?

A região é anestesiada e você pode sentir apenas pressão durante a aplicação. Um desconforto local nos dias seguintes é comum e passageiro.

P Em quanto tempo sinto diferença?

O efeito é gradual. A melhora costuma ser percebida ao longo de semanas a meses.

P Quantas aplicações são necessárias?

Muitas vezes, uma aplicação. O número é definido caso a caso, conforme a sua evolução.

P Posso continuar a fisioterapia?

Sim — e é recomendado. O movimento orientado potencializa o cuidado com a coluna.

P Substitui a cirurgia?

Quando a cirurgia é necessária, ela continua sendo o caminho. Em muitos outros casos, os ortobiológicos são uma opção a considerar antes.

P Posso tomar meus remédios?

Siga as orientações da consulta. Nunca suspenda remédios por conta própria, principalmente anticoagulantes.

Quando procurar atendimento rápido

São situações raras, mas importantes de reconhecer:

- ! Perda de controle da urina ou das fezes, ou dormência entre as pernas.
- ! Fraqueza que piora nas pernas ou nos braços.
- ! Dor nas costas com febre ou calafrios.
- ! Após o procedimento: vermelhidão, calor ou secreção no local da agulha.
- ! Dor que piora muito, em vez de melhorar, ou dor de cabeça forte ao ficar em pé.

192

Em emergência, ligue para o **SAMU (192)** ou procure o pronto-socorro. Para dúvidas após o procedimento, fale com a equipe: **WhatsApp (54) 99689-1295**.

proregen

Vamos conversar sobre a sua coluna?

Uma avaliação individual é o primeiro passo para entender a sua dor e escolher, com você, o melhor caminho.

AGENDAMENTO

WhatsApp (54) 99689-1295

proregen.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dr. André Kruel

Médico ortopedista

CRM-RS (CREMERS) 23627 · RQE 14323

Nota informativa. Este material tem finalidade exclusivamente educativa e não substitui consulta, diagnóstico ou indicação médica. Não há promessa de cura nem garantia de resultado; a resposta ao tratamento varia de pessoa para pessoa. As informações refletem estudos publicados até outubro de 2026 e podem ser atualizadas.

Normas do Conselho Federal de Medicina (CFM). A Resolução CFM nº 2.464/2026 reconhece o PRP como procedimento adjuvante (complementar) em condições específicas, entre elas a discopatia lombar; na coluna, deve ser realizado em hospital ou hospital-dia, guiado por imagem, com kits regularizados pela Anvisa e apenas com sangue do próprio paciente. Outros usos do PRP na coluna (como facetas, sacroilíaca ou coluna cervical) não constam dessa resolução e são discutidos individualmente. O uso de concentrado de medula óssea e de derivados de tecido adiposo em condições ortopédicas é considerado experimental pelo CFM (Parecer nº 43/2016, reafirmado em 2025; Parecer nº 2/2020) e só deve ocorrer em pesquisa aprovada por comitê de ética.

Fontes principais. Manchikanti L, et al. *Pain Physician*, 2026 (resumo das diretrizes ASIPP 2025); Manchikanti L, et al. *Curr Pain Headache Rep*, 2026; Navani A, et al. *Pain Physician*, 2024; Resolução CFM nº 2.464/2026; Anvisa, Nota Técnica nº 29/2024. Lista completa disponível com a equipe médica.

Ilustrações esquemáticas, fora de escala. Nenhum paciente é identificado. Sem preços, imagens de “antes e depois” ou depoimentos, conforme as regras de publicidade médica do CFM. Revisão: outubro de 2026.